今日課程順序

安寧療護
(安寧照顧)
(安寧照護)

介紹安寧
緩和療護

社區安寧
緩和療護

生命末期
老人照護

善終

不可以少安寧緩和醫療

哭著來到世界
如何微笑道別人間？？

醫療端

如何減少臨終前的痛苦

如何減輕失能重病之苦

協助照顧者幫助重病者

醫療的目的

解除痛苦

延長壽命

當兩者不能得兼時~

延長的是生命還是死亡過程？

醫療過度與醫療不足同樣傷害病人

最好的照顧 ≠ 最多的醫療措施

（插管、注射藥物、營養針.....）

盡可能延長生命≠

盡可能延長死亡過程

（prolonging dying ）

死亡套餐

- ☑ 轉加護病房
- ☑ 插管、上呼吸器、升壓劑
- ☑ 洗腎(H/D, CVVH)
- ☑ 全靜脈營養 /輸血
- ☑ CPR盡可能保持心電圖監測器上的生命徵象

What we do is to keep EKG until standstill.

--柯文哲醫師

上述這些治療，在什麼情況下能幫助病人？
何時對病人的負擔會超過效益？

「不得好死」？

不治之病、可療之症

•You matter because you are you,
•and you matter to the end of your life.
•We will do all we can
•not only to help you die peacefully,
•but also to live until you die.

~ Dame Cicely Saunders

你是重要的，因為你是你。
即使活到最後一刻，你仍然是那麼重要！
我們會盡一切努力，幫助你安然逝去；
但也會盡一切努力，讓你活到最後一刻！



Dame Cicely Saunders
西西里•桑德思女士

- 22歲成為護理師
- 27歲受洗為基督徒
- 29歲轉任社工師，

  癌末病人David Tasma告訴她：「如果你真想幫助癌症病人，就該去當醫生，因為是醫生遺棄了癌症病人。」
- 40歲成為醫師
- 49歲(1967)創辦

  St. Christopher ‘s Hospice



1918 - 2005



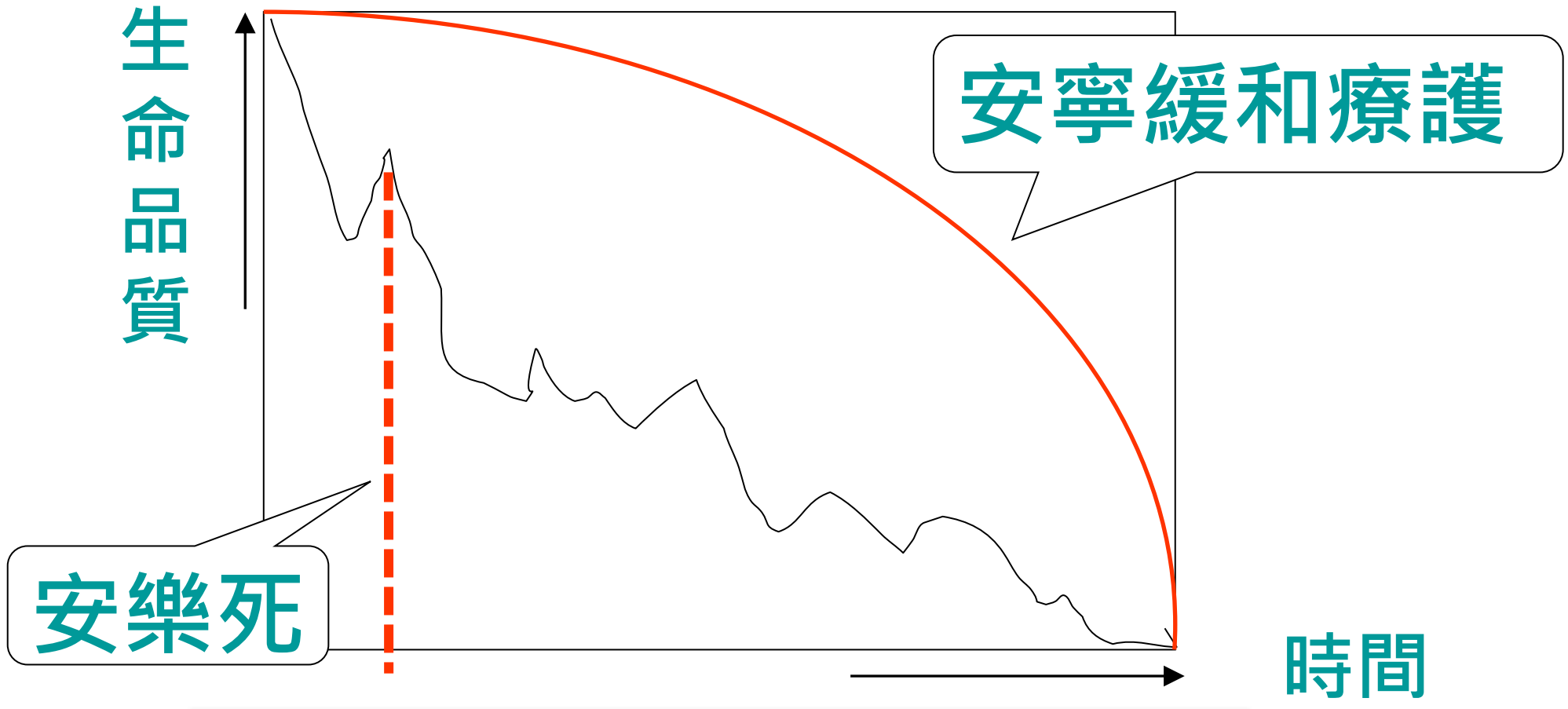
St. Christopher Hospice, London

HOSPICE 字源出處

- 中古世紀為朝聖者、旅人、陌生人、僧侶、貧苦及生病的人、盲人、老人、殘障的人，提供休憩、救援與安慰的房舍。



不可治癒末期疾病的自然病程

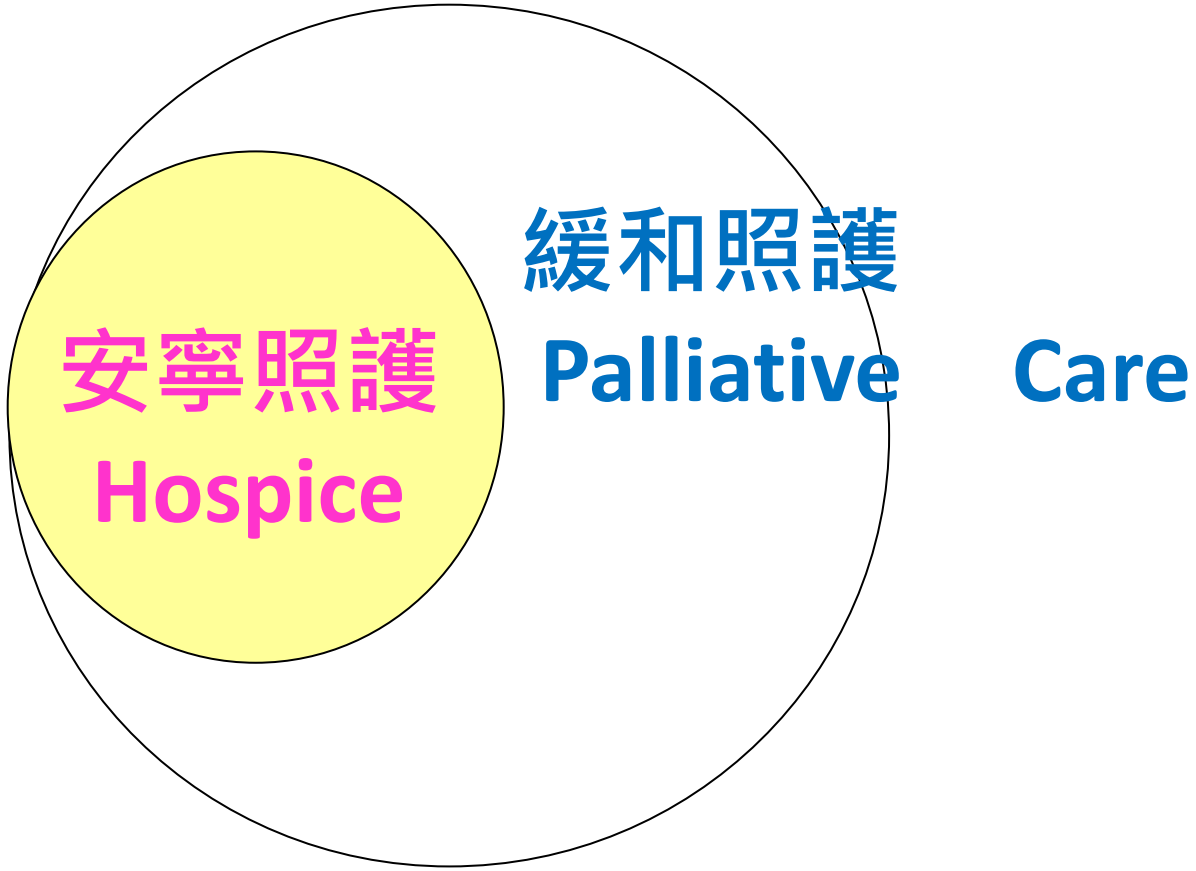


安寧療護主張安樂活

QQ

緩和照護(Palliative Care)

對象：任何重病者,不論其預期生命多久



安寧照護(Hospice Care)

對象：重病末期病人,預期生命已可預見

安寧緩和療護 (Hospice palliative care)

- 指為減輕或免除末期病人之生理、心理及靈性痛苦，施予緩解性、支持性之醫療照護，以增進其生活品質。(安寧緩和醫療條例,2000）

安寧緩和照護定義 (WHO, 2002年)

- 安寧緩和照顧為針對面對威脅生命之疾病的病人與家屬的一種照顧方式，其目標是藉由早期偵測及無懈可擊的評估與治療疼痛及其他身、心、靈的問題，預防及減緩痛苦，以達提升生活品質之目標。此定義中強調，安寧緩和照顧以團隊照顧的方式滿足病人及家屬的需求；提供病人疼痛及其他身、心、靈痛苦症狀的緩解，並協助家屬在病人的臨終期及病人死亡後的哀傷期（bereavement）的調適

World Health Organization. (2002). National cancer control programmes: Policies and managerial guidelines. (2nd ed.). Geneva: World Health Organization.

安寧緩和醫療照護重要理念

- 以病家為中心的照護。
- 注重溝通：

  病人及家屬間之溝通。

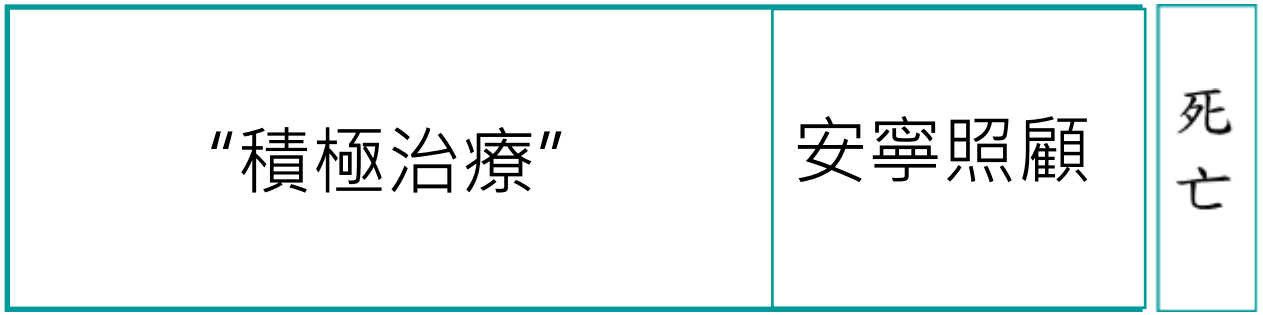
  病家及團隊成員間之溝通。

  團隊專業成員間之溝通。
- 用心聆聽，同理，及視病猶親。

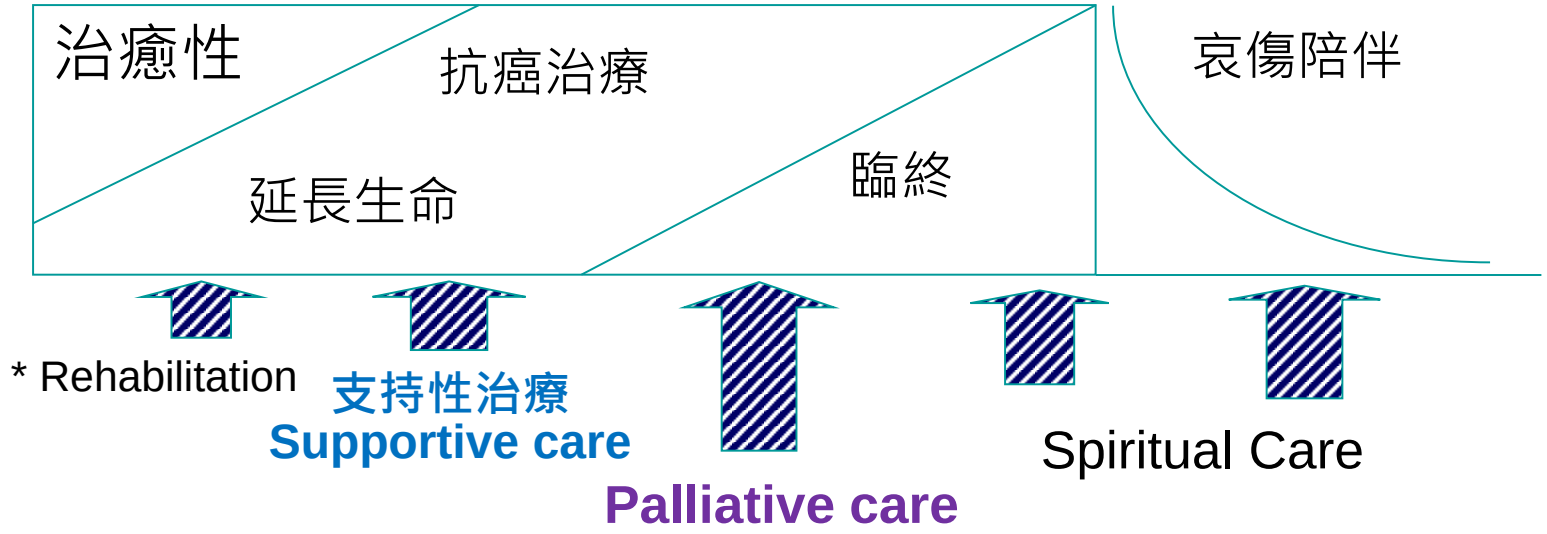


安寧緩和療護模式的發展

過去的觀念



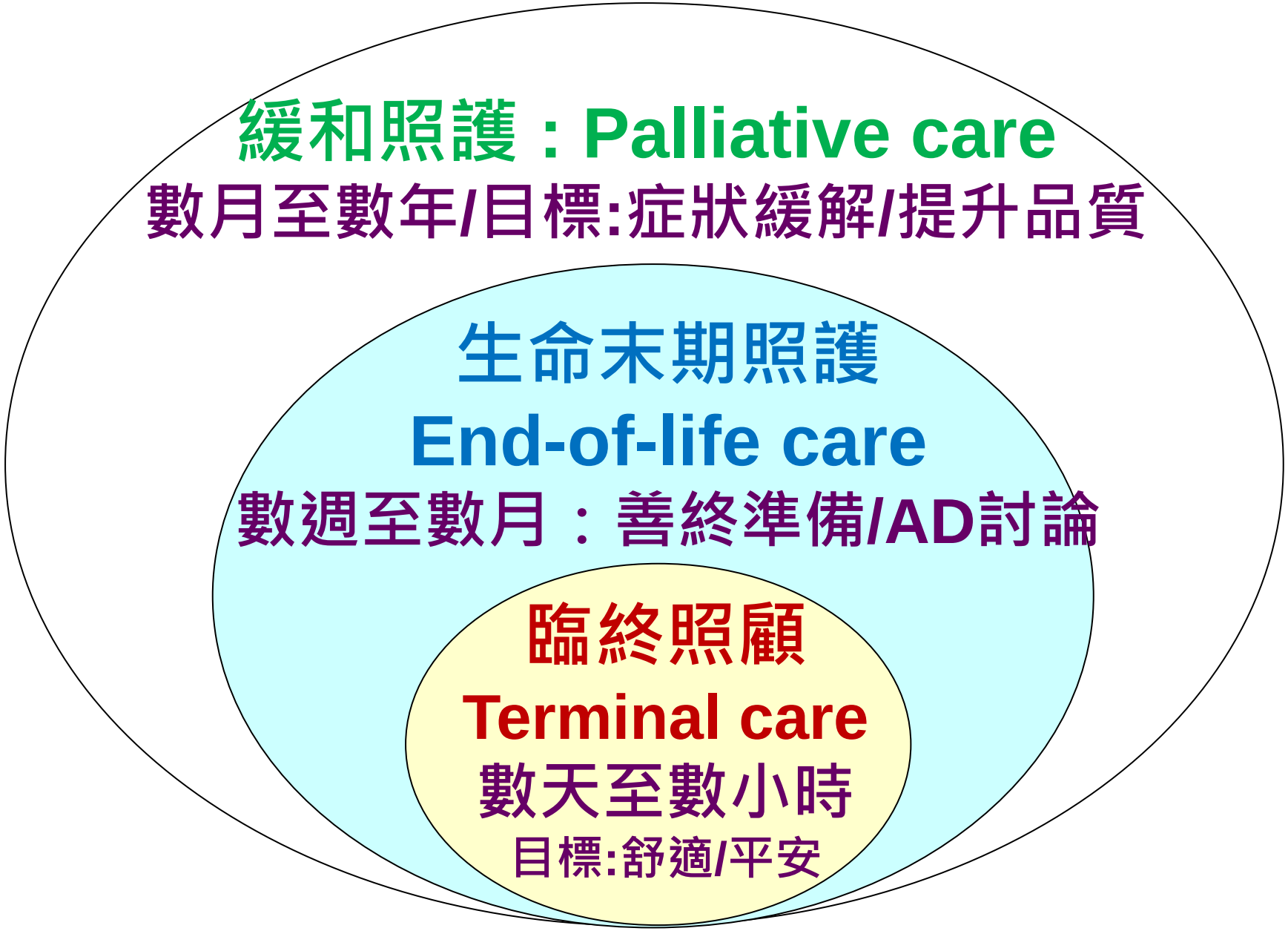
Sheffield Model (2000 Walsh) 以末期照護為主



Palliative care

(安寧)緩和療護

- 由跨領域多學科合作組成照護團隊
- 注重病人自主權的個別化整合式照護。
- 基於病人疾病和症狀需求。
- 以緩解病人症狀與促進舒適為導向。
- 連續性支持系統。
- 開放有效的溝通-病人、家屬及團隊人員間。


緩和照護：Palliative care
數月至數年/目標:症狀緩解/提升品質
生命末期照護
End-of-life care
數週至數月：善終準備/AD討論
臨終照顧
Terminal care
數天至數小時
目標:舒適/平安

安寧緩和醫療四全照顧

圓滿四道人生，讓生死兩相安

道謝

全人照顧

以病人為中心

注重身心靈整體需要

道歉

全隊照顧

結合跨領域多科團隊

團隊合作共同照顧



全程照顧

從壞消息揭露到臨終

至遺族悲傷關懷

道愛

全家照顧

不止照顧病人

也關心支持家屬

道別

WHA 67.19
May 2014

全球安寧緩和療護發展的分水嶺

安寧緩和療護是
全球醫療健康體系的道德責任

- WHA決議：安寧緩和療護不僅只是末期病人的需求，還應貫穿從生命早期到晚期的整個疾病過程。

Lancet

Oct 2017/March 2018

the Lancet Commission Report

嚴重健康相關痛苦 (SHS)

Serious Health-Related Suffering

SHS 指的是與任何種類的疾病或傷害相關的受苦：
當這些受苦無法在沒有專業介入的情況下緩解，
並且影響到身體、社會、精神和/或情緒功能時，
即可稱之為嚴重健康相關痛苦 (SHS)。

柳葉刀全球安寧緩和療護和疼痛緩解委員會

(Lancet Commission on Palliative Care and Pain Relief Study Group)

QQ

嚴重健康相關痛苦 (SHS)

Serious Health-Related Suffering

提倡 ➔ 安寧緩和療護新定義

- 強調痛苦(SHS)作為新定義的核心，
- 允許從以疾病為中心的概念，進一步轉變為更加以人為中心的方法。

主張PC應：根據需求而不是預後而提供，
適用於所有照護環境和級別，
涵蓋一般和專科照護。

常見的 SHS 癥狀類型

身體痛苦

- 中度或重度慢性痛
- 輕度慢性疼痛
- 虛弱
- 倦怠
- 呼吸困難
- 噁心和嘔吐
- 便秘
- 腹瀉
- 口乾
- 搔癢
- 傷口
- 出血

心理痛苦

- 焦慮和擔憂
- 憂鬱情緒
- 譫妄或混亂
- 定向障礙
- 激動不安
- 失智

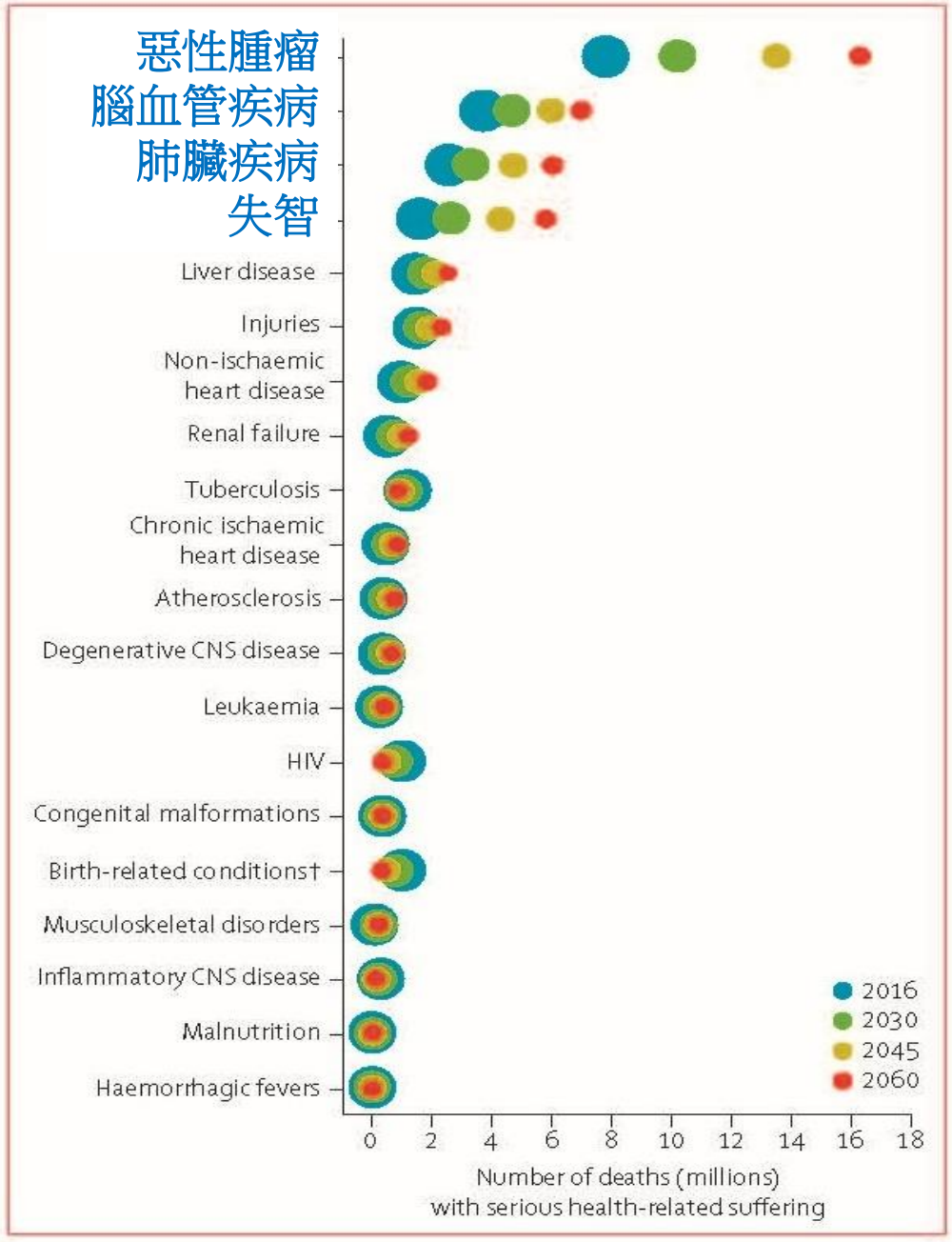
導致全球嚴重健康相關痛苦的疾病負擔

QQ

- 2016~2060，全球死亡總數：
  - 從5700 萬增加到 1 億以上。
  - 每年將有4800萬人死於SHS (佔全球死亡47%)
    (其中83%發生在中低收入國家)。

- 全球政策重點須關注於
  - SHS和緩和需求增長最快的人群：生活在**低收入國家、老年人和失智症患者**。

Sleeman, 2019



重新定義安寧緩和療護

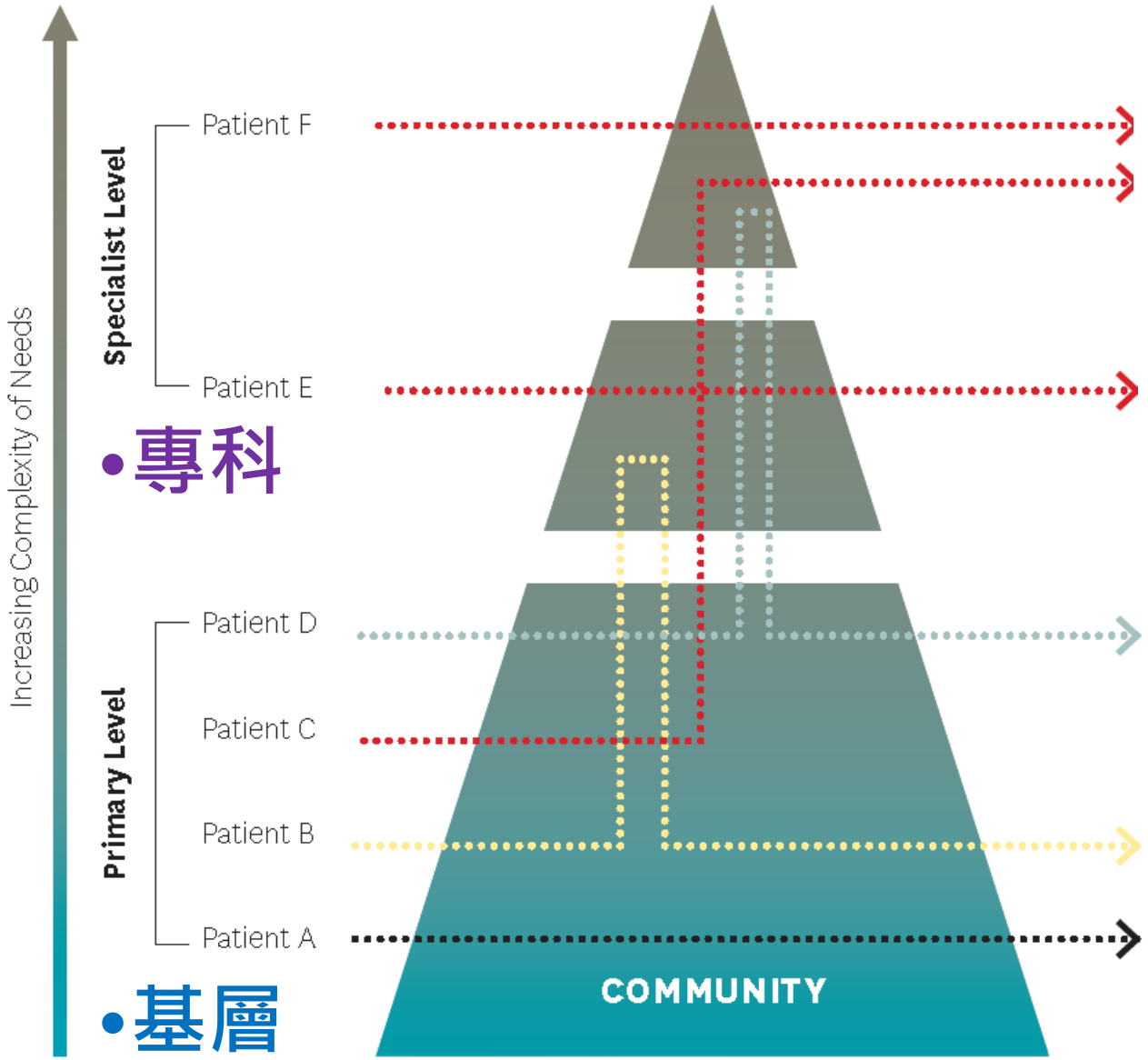
~經三階段至少412 位 IAHPC 成員接受邀請參與專家共識

安寧緩和療護(Palliative Care)：是對各年齡層患有健康方面出現嚴重受苦(SHS)的個體，進行積極的全面性照護。特別針對患有嚴重疾病，尤其是對那些接近生命終點的病人，以改善病人、其家人和照護者的生活品質。

- **嚴重疾病定義：**任何具有高死亡風險、對生活品質和日常功能產生負面影響和/或在症狀、治療或照顧者壓力方面造成負擔的急性和/或慢性疾病和/或健康狀況。

資料來源: http://pallipedia.org/serious-illness/

增加需求的複雜度



- 專科
- 基層

- **少數**有複雜需求的患者需要轉診至**專科安寧緩和療護服務**。
- 有些患者可能**偶爾需要**專科安寧緩和療護團隊協助（**會診**或**共同照護**支持。
- **大多數**患者只需要基層安寧緩和療護（安寧緩和照護方法）。
  - 家庭醫學診所
  - 腫瘤科團隊
  - 內科診所
  - 心臟科門診
  - 肺阻塞門診

Source: MacDonald 2019(15).

世界衛生組織建議安寧緩和醫療照顧計畫架構

Figure 3. Network of palliative care teams across the levels of health-care



各類相關疾病的安寧緩和療護指引









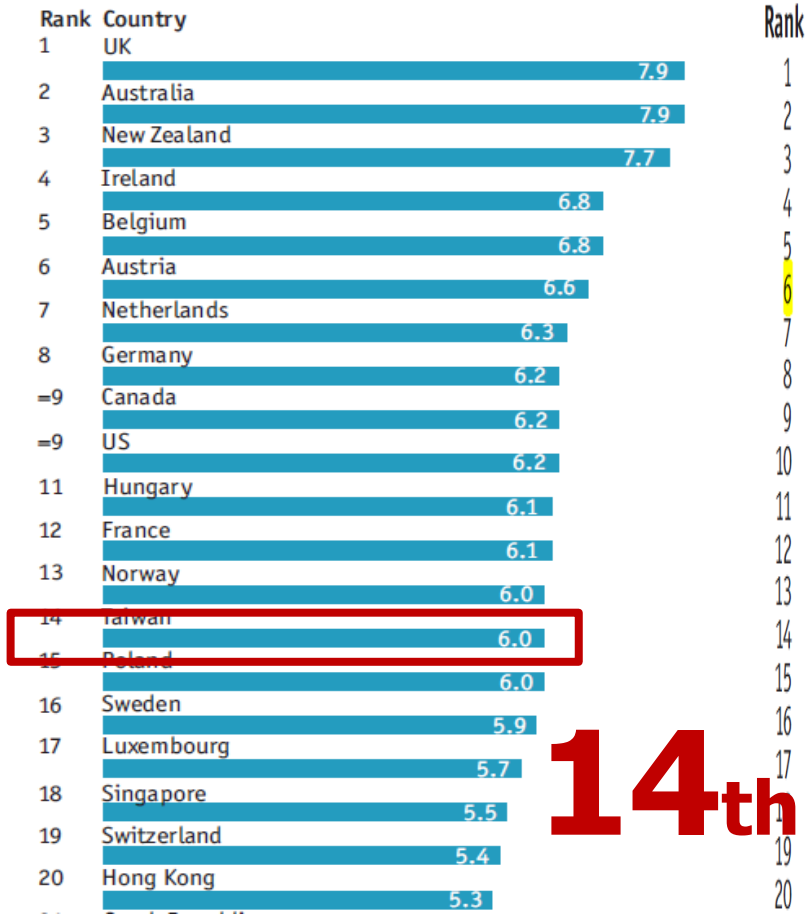






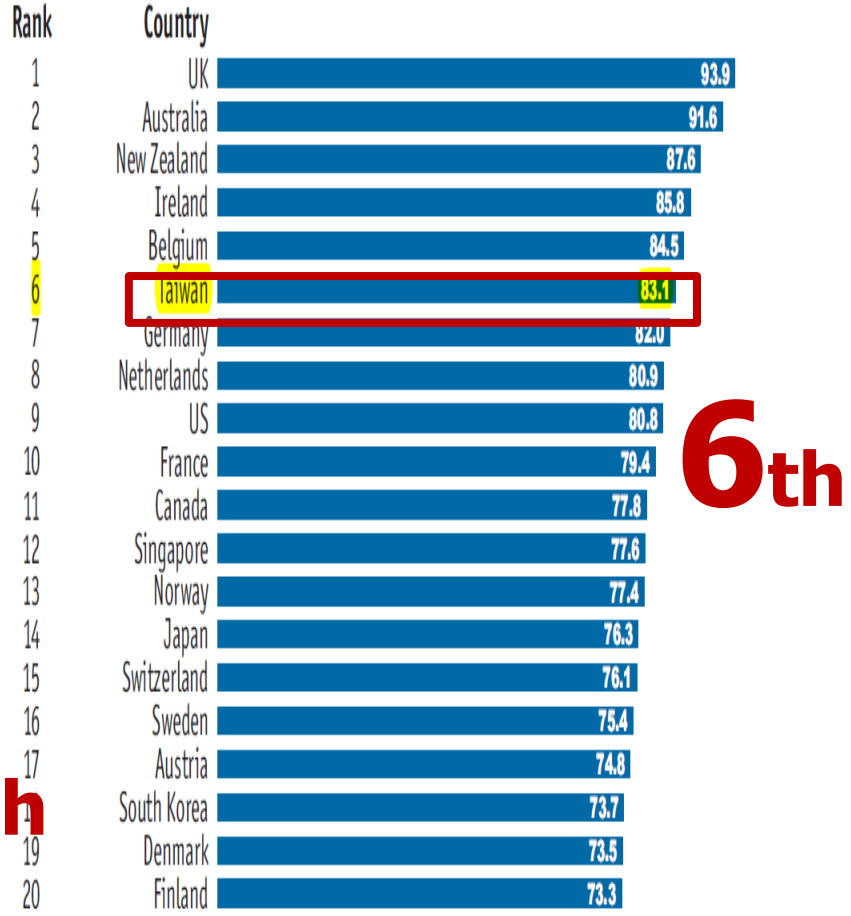
臺灣世界善終指數排名
Quality of Death Index

2010



14th

2015



6th

2021



3th

現行健保安寧給付規定(收案條件)

(一)符合安寧緩和醫療條例得接受安寧緩和醫療照護之末期病人（必要條件）。

(二)符合下列任一疾病之病人：（相關症狀條件詳附表）

1.癌症末期病人 (2000年起)

2.末期運動神經元病人 (2000年起)

3.主要診斷為下列疾病，且已進入末期狀態者：(2009年起)

(1)失智症 (2)其他腦變質

(3)慢性氣道阻塞，他處未歸類者 (4)肺部其他疾病

(5)慢性肝病及肝硬化 (6)心臟衰竭

(7)慢性腎衰竭及腎衰竭，未明示者 (8)急性腎衰竭，未明示者

(9)末期骨髓增生不良症候群(MDS) D46：(以下自2022年6月起)

(10)末期衰弱老人(R54)

4.符合病人自主權利法第十四條第一項第二款至第五款所列臨床條件者。

5.罕見疾病或其他預估生命受限者。

安寧緩和療護照護型態

照護型態	健保給付	臺灣目前發展概況
醫院附設安寧病房	V	全國安寧病房共86家，873床。
安寧共同照護服務	V	168家醫院開辦安寧共照服務
護理之家/養護所	—	僅少數提供機構安寧服務
獨立安寧院	—	無
日間照護	—	無
安寧居家照護	V	130家醫院開辦安寧居家服務
安寧特別門診	(V)	有安寧服務的醫院多有提供

以上資料統計至2024年7月止

安寧緩和醫療條例

•89年公布後經三次修訂

- 為尊重末期病人之醫療意願及保障其善終權益

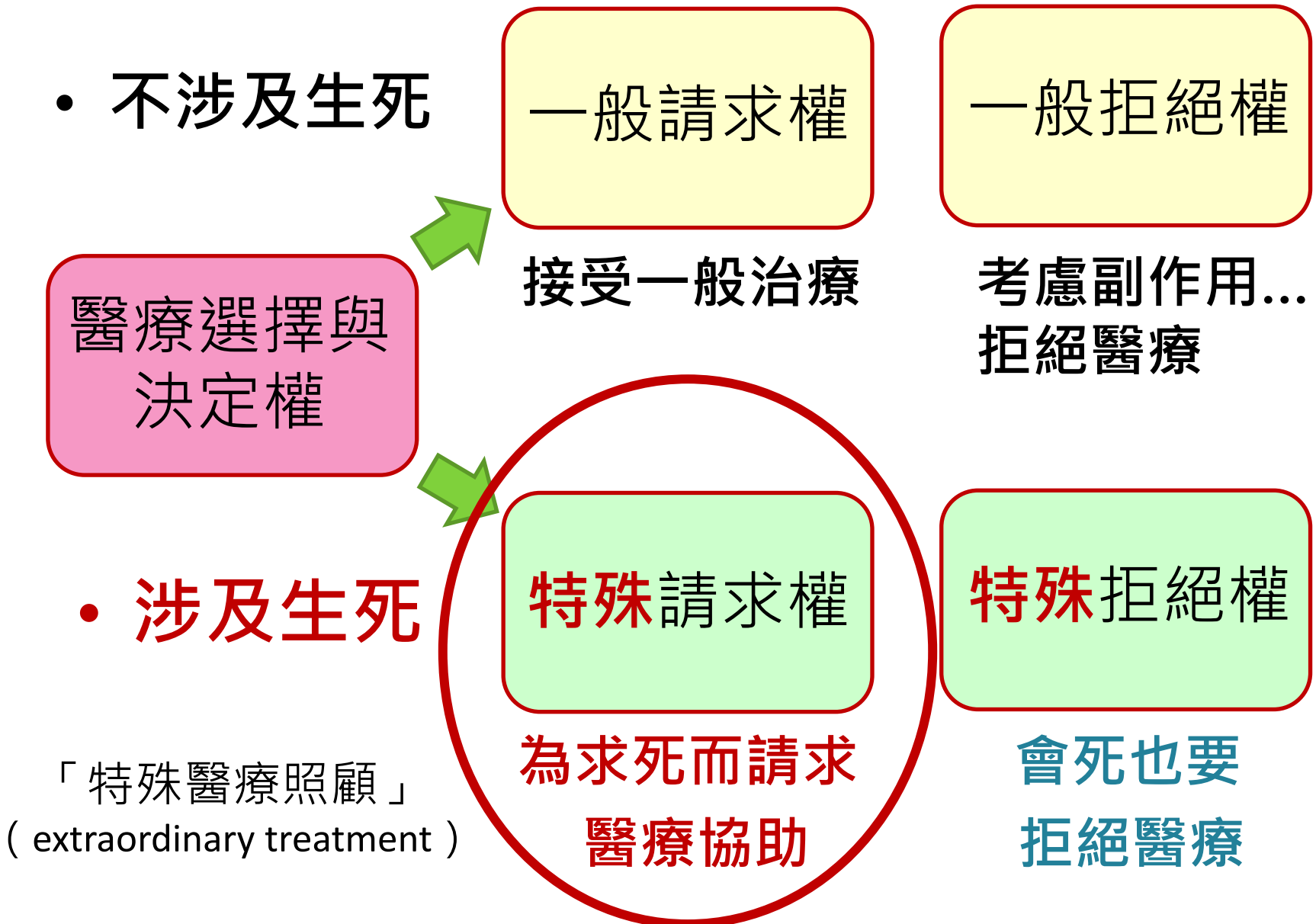


病人自主權利法

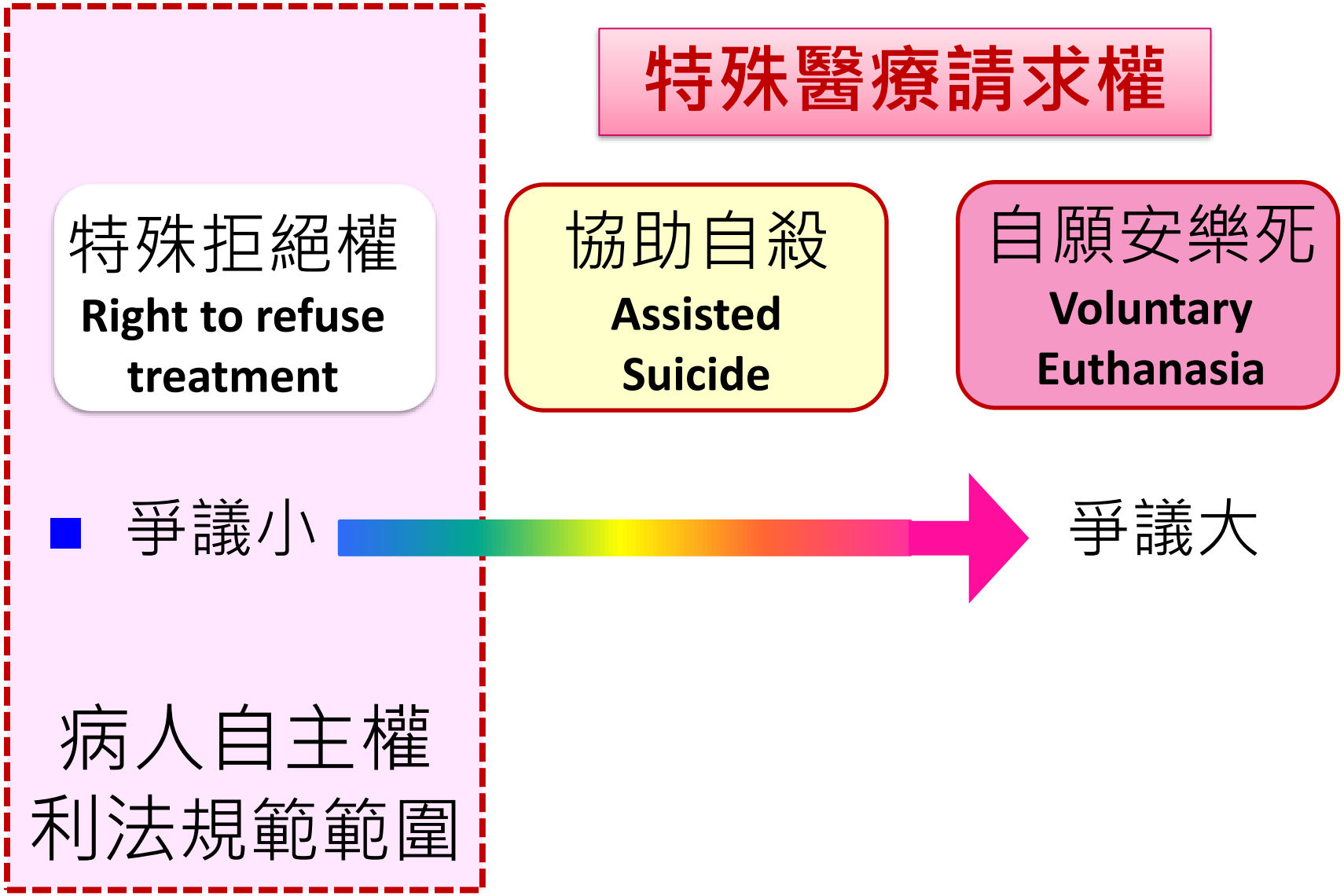
•105年1月6日公布

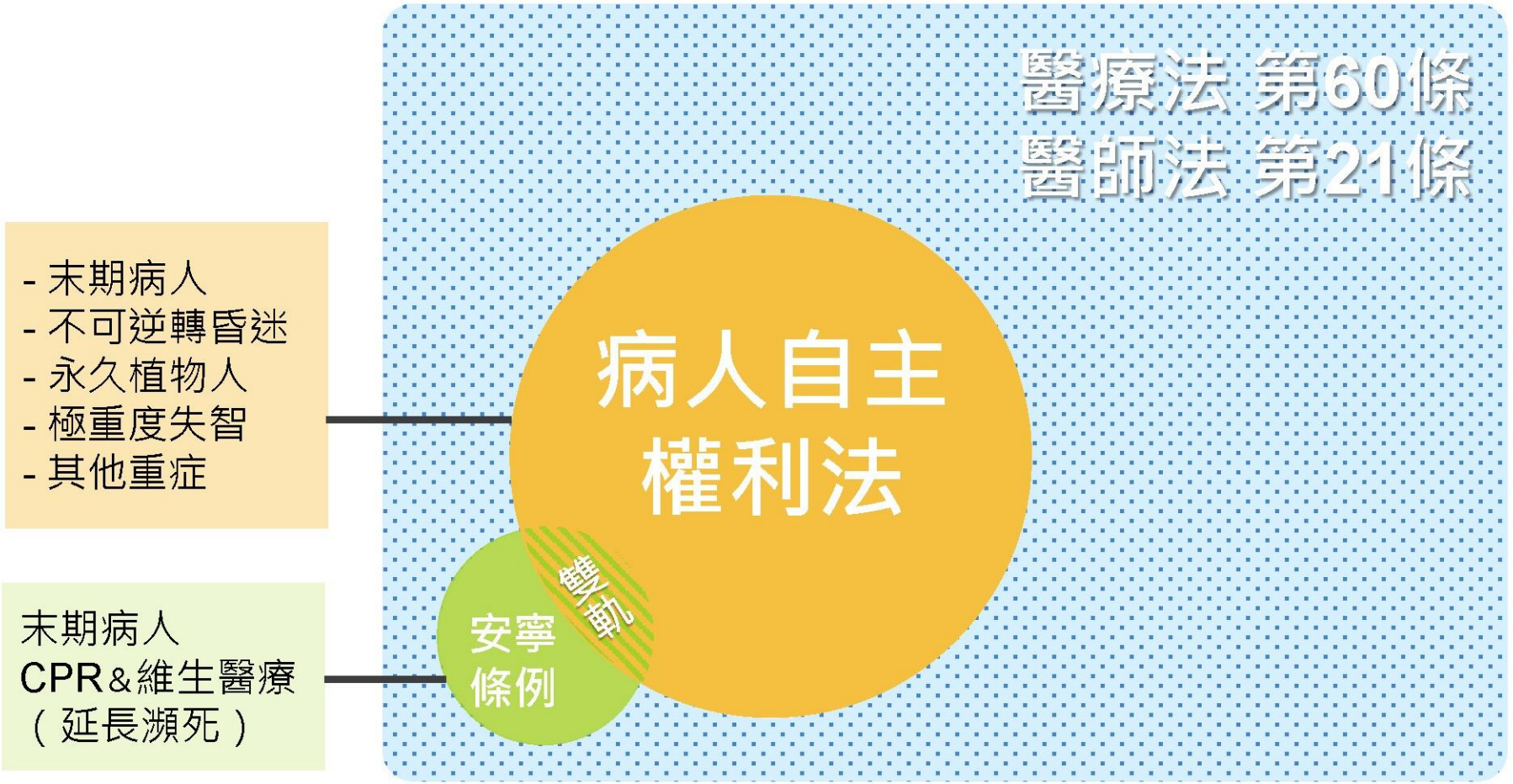
- 尊重病人醫療自主
- 保障病人善終權益
- 促進醫病關係和諧

行使特殊醫療拒絕權


• 不涉及生死
一般請求權
一般拒絕權
醫療選擇與決定權
接受一般治療
考慮副作用...
拒絕醫療
• 涉及生死
特殊請求權
特殊拒絕權
為求死而請求醫療協助
會死也要拒絕醫療
「特殊醫療照顧」
（extraordinary treatment）

QQ


特殊醫療請求權
特殊拒絕權
Right to refuse treatment
協助自殺
Assisted Suicide
自願安樂死
Voluntary Euthanasia
爭議小
爭議大
病人自主權
利法規範範圍



摘錄自楊玉欣委員辦公室【病人自主權利法說明】

QQ

維生醫療 Life-Sustaining Treatment

安寧緩和醫療條例§3

維生醫療抉擇

維生醫療：指用以維持末期病人生命徵象，但無治癒效果，而只能延長其瀕死過程的醫療措施

病人自主權利法§3-1

維持生命治療

心肺復甦術、機械式維生系統.....等

任何有可能延長病人生命之必要醫療措施。

拒絕
無效維生醫療

拒絕生活品質差
對我無益的治療

病人自主權利法SOP



具完全行為能力人

- 年滿二十歲
- 未滿二十歲已結婚
- 心智無缺陷

特殊醫療拒絕權

ACP
(advance care plan)

預立醫療照護諮商

AD
(advance directive)
(advance decision)

預立醫療決定

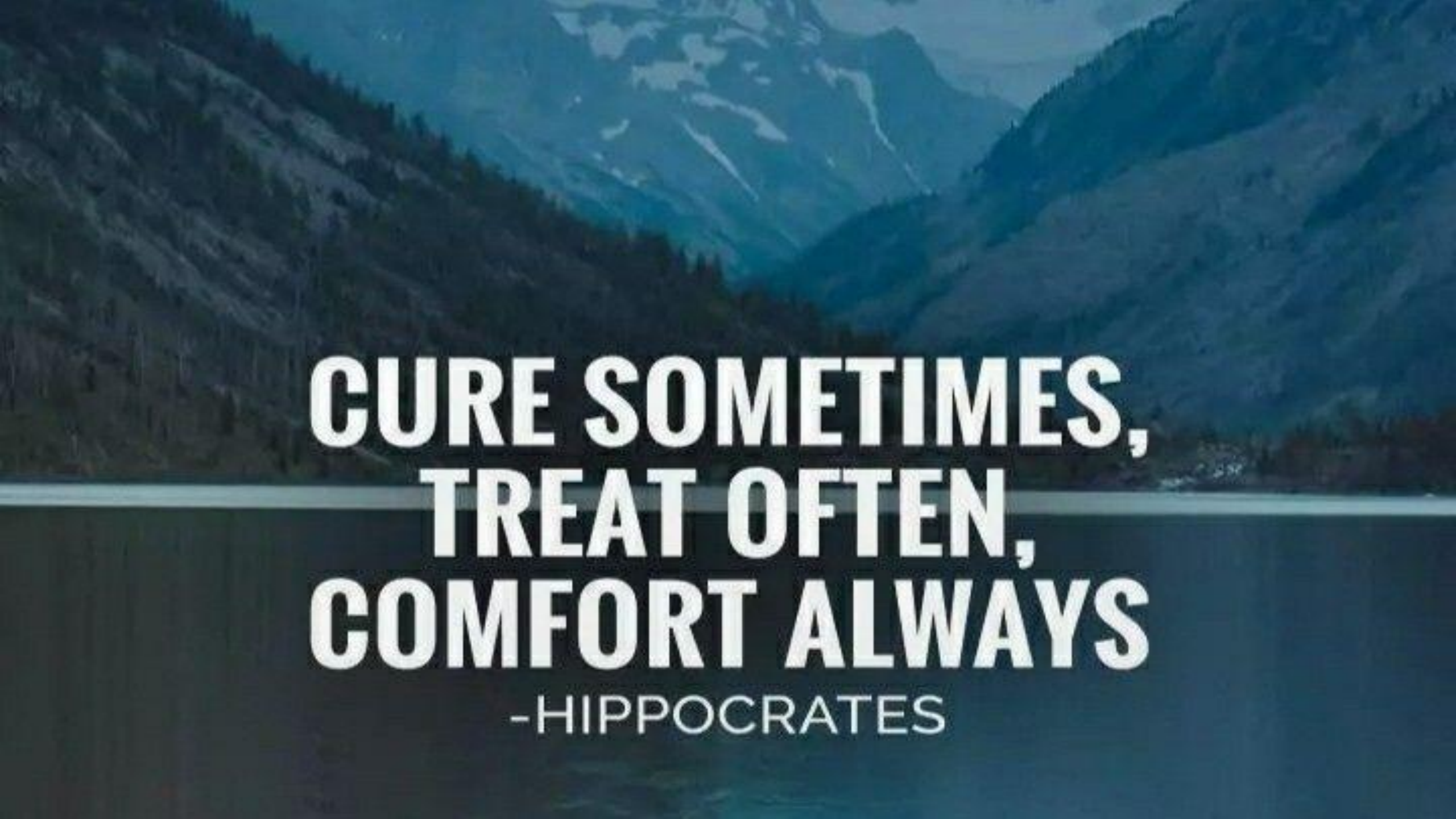
醫療委任代理人HCA
(Health Care. Agent)

1) 二位專科醫師確診
2) 緩和醫療團隊二次照會確認



符合下列任一款臨床條件時...

- 末期病人
- 不可逆轉的昏迷
- 永久植物人狀態
- 極重度失智
- 其他中央主管機關公告之重症


CURE SOMETIMES,
TREAT OFTEN,
COMFORT ALWAYS
-HIPPOCRATES

故事一：張老太太的下一步?

- 78歲張女士，長期服用高血壓、糖尿病與協助睡眠藥物
- 最近半年胃口不好、腹脹、體重減輕了2公斤
- 社區醫師轉介住院接受電腦斷層結果：
- **疑似第四期胃癌併肝轉移，惡性腹水及胸水**

治療建議：

1.建議胃鏡切片、腹膜或肋膜積水抽取化驗，評估化療可能性。

2.可反覆腹水抽吸或放置引流管

3.可放置人工血管或週邊中心靜脈管植入術(PICC)補充養份。

但病人不想做這些檢查。

- 張老太太沒有生育，先生已過世10年，她過去的身體狀況還算好，但自從**三年前跌倒**之後，行動較不方便，每天兩餐靠社區的送餐服務。
- **她不太想去住安養院，想在家中平安過世**。

醫療機構如何協助張女士規劃善終準備?

對張女士而言，目前最重要的是甚麼?未來會擔心甚麼事?

她的偏好與價值觀是甚麼?

- 安寧居家照護微電影(14:41)

https://youtu.be/qmU15suCefk

(鄭人碩主演)

社區安寧療護

- 【在家善終 安寧照護社區化】華視新聞雜誌
  https://youtu.be/5LK55Gi6NHk (11:14)
- 雙溪肺癌老人居家安寧報導　https://youtu.be/PKid_Sijz64 (3:36)
- 堅持落葉歸根 頭目闔眼返“天家“　https://youtu.be/ivDiJJdlluA (3:45)
- 歡迎參觀臺北榮總安寧病房(10:32)
  https://youtu.be/XktlsKff9fk
- 臺北榮總安寧緩和服務介紹網路資源
  https://www.dahder.org.tw/publicUI/D/D105.aspx

以下為課堂補充資料

HOSPICE (好死必死)

五大目標

- 內心衝突之消除
- 人際怨懟之復合
- 特殊心願之實現
- 未竟事務之安排
- 親朋好友之告別

西西里•桑德思

Hospitality（親切）
Organized care（團隊照顧）
Symptom control（症狀控制）
Psychological support（心理支持
Individualized care（個人化照顧）
Communication（溝通）
Education（教育）

- 日本大阪柏木哲夫教授（T. Kashiwagi）

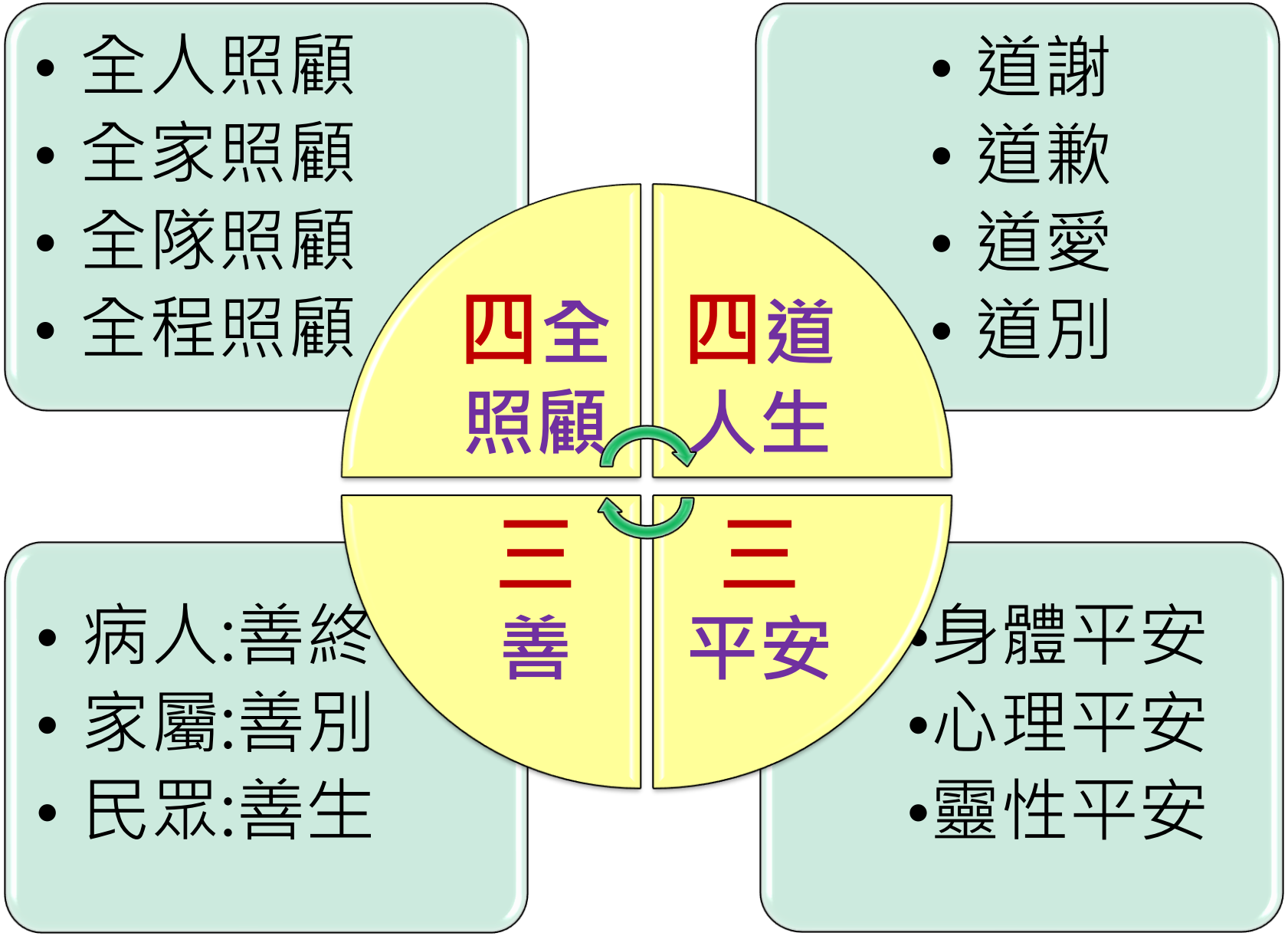
近代安寧療護運動推展

- 英國：1967第一家安寧院創立。
- 美國：1974第一所安寧院。
- 日本：1981聖隸安寧院。
- **臺灣**：1990馬偕醫院**安寧病房**
  （臺北淡水竹圍）

臺灣安寧緩和療護發展史

1. 1990 馬偕醫院安寧病房(第一所)
2. 2000 安寧緩和醫療條例 /健保試辦計畫（癌症、運動神經元疾病)
3. 2004 試辦住院安寧共同照護計畫
4. 2009 健保正式給付安寧住院/居家
   (癌症、運動神經元疾病、新增8類非癌症疾病）
5. 2016 病人自主權利法（2019正式實施）
6. 2019 臺灣安寧緩和療護政策白皮書
7. 2020 臺灣安寧緩和療護政策綱領暨行動方案
8. 2022 健保擴大安寧療護收案對象，再增列老衰等4類病人

趙可式教授：生生世世的照護觀念



1995-2005年
政府主導推動安寧緩和療護

第一波運動

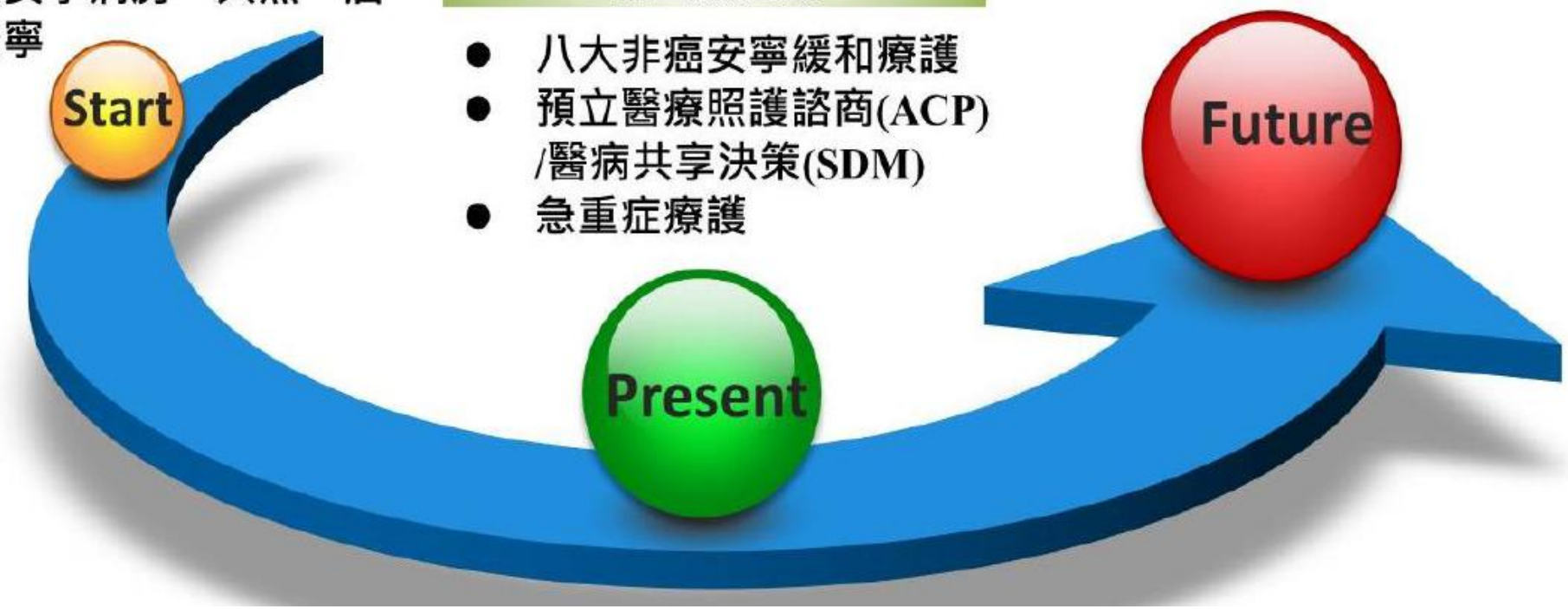
- 引進安寧緩和療護的概念
- 制度建立、立法保障善終
- NGO、專業學會成立
- 以癌症為主
- 發展安寧病房、共照、居家安寧

2006-2015年
第二波運動

- 八大非癌安寧緩和療護
- 預立醫療照護諮商(ACP)/醫病共享決策(SDM)
- 急重症療護

2016-2025年
第三波運動

- 不分疾病安寧緩和療護
- 全齡人口安寧緩和療護
- 早期介入安寧緩和療護
- 社區與長照安寧緩和療護
- 新科技與AI人工智慧醫療
- 病人自主權利法
- 慈悲關懷社區/城市



全民健保給付安寧療護

	住院安寧	安寧居家	乙類安寧居家 (社區安寧)	安寧共照
試辦日期	2000年7月	1996年7月	-	2011年4月
導入支付	2009年9月1日起		2014年起	-
	每床每日 6409點	• 在宅醫師訪視每次 1553點 • 在宅護理訪視每次 2250點 (不滿一小時為 1650點) 乙類安寧給付七折/機構給付八折 • 臨終病患訪視費 5000點 • 山地離島訪視加1成		首次照護 2025點 後續團隊照護 每週1575點 (不含醫師 1275點)
對象	癌症末期、漸凍人及八大非癌症末期病人 老衰病人...請參考下頁說明			

臺灣安寧居家療護健保訪視規定

六、 訪視次數之規定

現行健保規定安寧居家護理師訪視次數為每一名個案每週以兩次為原則，醫師訪視次數每一位個案每周以一次為原則，若病人病情有顯著變化需要多於此頻次者，將由安寧居家團隊視病人狀況適時調整之。

七、 服務時間

安寧居家療護小組上班時間為星期一至星期五 8:00~17:30，連絡電話(02)2875-7699 或院內專線 PHS:8#0887；非上班時間提供安寧病房 24 小時諮詢服務電話(02)2875-7211。

八、 常見問題

Q1: 「安寧居家療護」只接受住在家裡的對象申請嗎？

答: 只要符合「安寧居家療護」收案條件的末期症狀病人，都是安寧居家療護服務的對象，所以不管病人是住在護理之家或安養機構皆可以提出申請，並不限定個案的居住場所。

臺北榮民總醫院安寧居家療護轉介醫囑單

一、 個案資料：

請貼 STICK 姓名、病歷號、出生日期 **診斷：**	**收案類別(請勾選)：** ☐ **惡性腫瘤末期** ☐ 不接受呼吸器處理之末期運動神經元疾病人者 ☐ 老年期及初老期器質性精神病態末期 ☐ 其他大腦變質末期 ☐ 末期心臟衰竭	☐ 末期慢性氣道阻塞疾病 ☐ 末期肺部其他疾病 ☐ 末期肝病及肝硬化 ☐ 急性腎衰竭末期 ☐ 慢性腎衰竭及腎衰竭末期 **（非癌末期條件詳見後頁附表）**

收案條件查檢表（全數勾選“是”，方符合收案）。

是	否	
☐	☐	病人或家屬同意接受安寧療護，並已簽署本院 DNR 意願書或健保 IC 卡已註記登錄「預立選擇安寧緩和醫療意願」。
☐	☐	病人或家屬是否了解為末期疾病，並確定對各種治癒性治療效果不佳。
☐	☐	病人是否為 **ECOG** 2 級以上或 Karnofsky Performance Scale 50-60 分。
☐	☐	病人或家屬了解需自行負擔安寧居家護理師來回計程車資。
☐	☐	病人居住地位於臺北市、新北市且距離臺北榮總 30 分鐘車程內。

疾病診斷與轉移處：_____

意識狀態：☐清醒 ☐嗜睡 ☐混亂 ☐昏迷：E__M__V__

主要聯絡人：_____ 與個案關係：_____ 聯絡電話：_____

居住地址：_____

二、個案主要安寧居家照護技術性需求項目：

留置管之定期更換：□鼻胃管 □導尿管 □氣切管　更換日與規格：_____

□傷口護理（壓傷/手術/腫瘤潰瘍）：_____

□造口護理：□人工肛門 □胃造口 □膀胱造口 □氣切造廔口 □PCN □其他_____

□止痛處置加藥、更換及皮下注射：_____

□人工血管之護理：沖洗時間及注意事項_____

□舒適護理 □善終準備 □身體其他照護需求_____

三、個案居家社會、心理及靈性照顧需求轉介：

□居家福利資源評估 □家庭功能評估與處遇 □預期性悲傷評估與處遇

□情緒狀態評估與處遇(□情緒低落 □生氣易怒 □恐懼害怕 □焦慮不安 □情緒變化大)

□行為狀態評估與處遇(□自傷傷人 □破壞行為 □迴避退縮 □自主尊嚴 □脫序行為)

□認知狀態評估與處遇(□自殺意念 □負向思考 □認知固著 □疑心妄想 □思考跳躍)

□生命與死亡之存在議題(死亡、孤獨、自由、無意義)的評估與處遇

□靈性阻礙與宗教信仰 □其它(如心理精神症狀、陪伴困難與壓力等)_____

四、目前病情及使用藥物：

_____

_____

轉介醫師蓋章：_____ **分機：**_____ **日期：**____年____月____日